

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 10

Accident Exposition Au Sang



06 16 03 08 31



slit-anass

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

INTRODUCTION

Les professionnels de santé ont toujours été exposés à différents types de risques y compris les accidents exposant au sang (AES), qui constituent un problème de santé publique.

D'après l'organisation mondiale de la santé (OMS), presque trois millions professionnels de santé en sont victimes annuellement. La prévalence diffère selon les pays, ce qui peut être expliqué par les conditions du travail et la disponibilité des équipements de prévention.

L'AES est considéré comme l'une des principales causes des accidents de travail. Il se définit comme « **tout contact avec du sang ou un liquide biologique contenant du sang et comportant soit une effraction cutanée (piqûre, coupure) soit une projection sur une muqueuse (œil...) ou sur une peau lésée.** ». Après un tel accident, il y a plusieurs germes qui peuvent être transmis : virus, bactéries, parasites et champignons. Mais, les plus fréquemment retrouvés sont le virus de l'hépatite B (VHB), le virus de l'hépatite C (VHC) et le virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Ainsi, après un AES, la transmission du VHB varie entre 6 % et 30 %, le risque de contamination par le VHC est de l'ordre de 0 à 10 %. Le risque de transmission du VIH est, quant à lui, estimé à 0,3 %. Notant bien que presque 78,5 % des cas des AES sont secondaires aux lésions percutanées.

1. Les AES:

Tout contact avec du sang, un liquide biologique contenant du sang, un liquide biologique non visiblement souillé de sang mais considéré comme potentiellement contaminant tel que liquide céphalo-rachidien, liquide pleural, sécrétions génitales... lors d'une piqûre ou d'une coupure avec un objet contaminé (seringue, scalpel...), d'un contact sur peau lésée, d'une projection sur une muqueuse (œil, bouche, nez)

2. Les éléments suivants ne sont pas considérés comme un AES :

- ❖ Piqûre ou coupure avec un matériel neuf ou stérilisé non encore utilisé.
- ❖ Piqûre ou coupure avec un matériel souillé qui est entré dans un processus de décontamination et nécessite une évaluation spécifique pour déterminer s'il existe encore un risque de transmission virale.
- ❖ Contact cutané-muqueux avec un liquide biologique non contaminant (ex : urines).
- ❖ Contact des gants avec du sang.
- ❖ Projection de salive sur la peau ou le visage.
- ❖ Contact cutané-muqueux suivi d'une désinfection dans les 15 minutes.
- ❖ Présence de sang sur une paillasse, un matériel de soins.

3. La prévention des AES

- ❖ L'évaluation des risques des différentes pratiques et la surveillance des AES par l'étude des circonstances de survenue de ces accidents permettant ainsi d'identifier les facteurs de risque, les gestes à risque ainsi que les catégories de personnel les plus exposées au risque d'AES dans le but d'orienter la prévention par l'unité de santé au travail
- ❖ L'implication de la sécurité dans l'organisation du travail
- ❖ La disponibilité de matériel de protection adapté : il est préférable d'utiliser du matériel à usage unique et des dispositifs médicaux de sécurité
- ❖ L'information et la formation du personnel sur les procédures de soin et l'utilisation du matériel
- ❖ La diffusion d'une conduite à tenir (CAT) en cas d'AES qui doit être connue par tout le personnel
- ❖ L'application des précautions standards de prévention pour réduire les risques de contamination du personnel lors de la manipulation des liquides biologiques qui doivent être considérés d'emblée comme infectants.

Ces mesures de prévention visent ainsi à réduire le contact avec le sang pour éviter la contamination et doivent être appliquées dans tous les établissements de soin. Elles englobent :

- ✓ Le respect des recommandations en vigueur concernant le lavage et la désinfection des mains, notamment le lavage immédiat en cas de contact avec des liquides biologiques potentiellement contaminants et systématiquement après tout soin, après le retrait des gants entre deux patients ou deux activités
- ✓ Le Port de gants qui est nécessaire s'il y a un risque de contact avec du sang ou tout autre produit d'origine humaine avec les muqueuses ou la peau lésée d'un patient.
- ✓ Le respect des bonnes pratiques par le personnel de santé est essentiel lors de toute manipulation d'instruments piquants ou coupants souillés en restant vigilant et en veillant à :
 - Ne jamais recapuchonner les aiguilles
 - Ne pas désadapter à la main les aiguilles des seringues ou des systèmes de prélèvement sous-vide
 - Jeter immédiatement sans manipulation les aiguilles et autres instruments piquants ou coupants dans un conteneur adapté, situé au plus près du soin, dont l'ouverture est facilement accessible et en ne dépassant pas le niveau maximal de remplissage
 - Manipuler avec précaution en cas d'utilisation du matériel réutilisable, lorsqu'il est souillé et en assurer rapidement le traitement approprié.
- ❖ La gestion des déchets des activités de soin.

4. Le protocole de prise en charge des victimes des AES

a. La prophylaxie post exposition au VIH (PPE)

- ❖ Elle représente un moyen de prévenir la transmission VIH à une personne séronégative qui aurait été exposée au virus dans un cadre professionnel (AES) ou non professionnel (personne s'injectant des drogues ou exposition sexuelle). Elle consiste à administrer un traitement antirétroviral (ARV) le plutôt possible dans les 4 heures et au plus tard dans les 72 heures suivant une exposition au VIH.
- ❖ La PPE comprend les premiers soins, la délivrance de conseils, le dépistage de l'infection VIH, de l'HVB et l'HVC et l'administration d'un traitement ARV pendant 28 jours avec un suivi médical.

b. Mesures générales devant un accident d'exposition au sang : 0 à 15 min

Arrêter le geste en cours et se faire remplacer par un collègue

En cas de piqure, coupure ou projection sur la peau lésée :

- ❖ Ne pas presser ni faire saigner
- ❖ Nettoyer la plaie et la peau à l'eau courante et au savon
- ❖ Désinfecter longuement (3 à 5 minutes) en plongeant la zone lésée dans une solution antiseptique, sinon en appliquant un pansement imbibé de produit par ordre de préférence :
 - ✓ Chlorhexidine
 - ✓ Antiseptique : polyvidone iodée, Dakin, alcool à 70° avec un temps de contact de 5 à 10 min minimums
 - ✓ Eau de Javel à 12% dilué à 1/10

En cas d'une projection sur muqueuse

Il faut rincer abondamment les muqueuses avec de l'eau ou au sérum physiologique pendant 10 minutes au minimum, en évitant d'utiliser des solutions caustiques ou irritantes (eau de javel, alcool). En cas de port de lentilles de contact, il faut les enlever et les rincer.

Contacter le Service des Urgences où le médecin procédera à : 15 min à 4h

- ❖ Une évaluation du risque de transmission des agents infectieux (VIH, HVB, HVC ...)
- ❖ La dispensation, si indication, d'une Prophylaxie du VIH, basée sur un traitement antirétroviral (ARV)
- ❖ L'indication d'une vaccination contre l'hépatite B (si la personne exposée est non immunisée)
- ❖ L'établissement d'un certificat médical initial pour la déclaration de l'accident

Consulter le médecin de travail qui va assurer : J1 à J7

- ❖ Le suivi clinique et biologique de l'AES, qui sera conduit pendant les 6 mois suivant l'AES
- ❖ L'analyse des circonstances de l'AES, afin d'orienter le renforcement des mesures de prévention

Conduite à tenir administrative :

- ❖ Déclarer à l'administration dans un délais ne dépassant pas les 48 H
- ❖ Informer le chef hiérarchique
- ❖ Remplir les imprimés de déclaration de l'Accident de Travail

Evaluation du risque

L'évaluation en cas d'AES se fait par l'examen de la plaie en précisant les éléments suivants :

- ❖ La profondeur de la blessure (superficielle ou profonde), piqure ou coupure
- ❖ Le temps d'exposition au sang ou liquide biologique > 15 minutes
- ❖ Le Liquide biologique en cause : sang ou autre liquide biologique
- ❖ Le Matériel en cause : coupure avec bistouri, piqure avec aiguille IV, IM ou SC, aiguille abandonnée
- ❖ Piqure avec aiguille pleine ou vide
- ❖ Morsure

5. Evaluation du statut sérologique et vaccinal de la personne exposée :

- ❖ Il faut préciser le statut sérologique de la personne exposée pour savoir si elle ne porte pas déjà les virus précités à l'état asymptomatique car la PPE est destinée uniquement aux personnes séronégatives.
- ❖ Les examens sérologiques concernant le VIH ainsi que le VHB et VHC, doivent être pratiqués le plus tôt possible après une exposition au sang ou sexuelle (avant le 8ème jour), puis à S6 et S12. Les prélèvements à réaliser sont :
 - ✓ La Sérologie VIH
 - ✓ La Sérologie VHB : Ac anti HBs si vacciné et titrage quantitatif des Ac, Ag HBs, Ac anti HBc
 - ✓ La Sérologie VHC
 - ✓ Les ALAT
- ❖ La sérologie de la syphilis si exposition sexuelle. La détermination du statut vaccinal de l'hépatite B de la personne exposée.

6. Indication de la prophylaxie post exposition

L'indication de la prophylaxie post exposition (PPE) dépend des informations collectées telles que le délai entre la consultation et l'exposition, la nature de l'exposition (au sang, sexuelle ou survenue lors de l'usage de drogues IV), les caractéristiques de l'exposition (faible, modérée ou importante) et le statut VIH du patient source.

La PPE doit être démarré d'urgence et poursuivi pendant 28 jours tout en informant la personne exposée sur les ARV et leurs effets secondaires. La personne qui reçoit les ARV doit prendre les mesures standards de précaution durant toute la période de suivi. Il faut également conseiller l'usage du préservatif et de la contraception ; déconseiller l'allaitement, le don de sang, sperme ou organe et évaluer et prendre en charge les autres risques.

- ❖ Si le délai d'exposition est inférieur à 72 H et le statut VIH de la personne source est positif, la PPE est recommandée quel que soit le niveau de risque et la nature de l'exposition.
- ❖ Si le délai d'exposition est inférieur à 72 H et le statut VIH de la personne source est inconnu, la PPE est recommandée uniquement lorsque le niveau de risque de l'exposition est important.

La PPE doit être démarrée en urgence et poursuivie pendant 28 jours tout en informant la personne exposée sur les ARV et leurs effets secondaires.

7. Précautions standards pour éviter les AES :

- ❖ Ne jamais recapuchonner les aiguilles.
- ❖ Ne pas dégager à la main les aiguilles de seringues ou des systèmes de prélèvements sous vide.
- ❖ Jeter immédiatement les aiguilles et autres objets piquants ou coupants dans un conteneur adapté et imper forable.
- ❖ Porter les gants pour tout risque de contact avec du sang, un liquide biologique contaminant...
- ❖ Protéger tous plaies avant mettre les gants.
- ❖ Se laver les mains après le retrait des gants, entre deux patients ou deux activités.
- ❖ Porter un masque, les lunettes, une surblouse...
- ❖ Décontaminer immédiatement les instruments utilisés, les surfaces souillées par le sang...
- ❖ Se faire vacciner contre VHB...